



Collection MedWIZ

5^e année médecine

ENDOCRINOLOGIE- MALADIES MÉTABOLIQUES

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Définition et classification du diabète sucré	8				
02	Prise en charge thérapeutique du diabète sucré	12				
03	Complications aiguës du diabète sucré	14				
04	Complications chroniques du diabète sucré	16				
05	Goitre simple et troubles de la carence iodée	18				
06	Hypothyroïdies	20				
07	Hyperthyroïdie	22				
08	Thyroïdites	24				
09	Cancers de la thyroïde	26				
10	Dyscalcémies	28				
11	Insuffisance antéhypophysaire (IAH)	32				
12	Adénomes hypophysaires	34				
13	Diabète insipide	36				
14	Syndrome de cushing	38				
15	Hirsutisme	42				
16	Syndrome métabolique	44				
17	Obésité	46				
18	Dyslipidémies	48				
19	Hypertension artérielle endocrine	50				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
25	Aménorrhées endocriniennes	54				
26	Nutrition et prévention des maladies cardiovasculaires	56				
27	Gynécomastie	58				
28	Antidiabétiques	62				
29	Nodule thyroïdien	64				
30	Dysthyroïdies de la femme enceinte	66				
31	Explorations radiologiques en endocrinologie	68				
32	Explorations biologiques en endocrinologie	70				
33	Iconographie en endocrinologie	72				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

DÉFINITION ET CLASSIFICATION DU DIABÈTE SUCRÉ (1)

I. HISTORIQUE ET DÉCOUVERTE DE L'INSULINE

- 1869 : Langerhans découvre les îlots pancréatiques
- 1889 : Minkowski → diabète par ablation du pancréas chez le chien
- 1921 : Banting et Best → extraits pancréatiques hypoglycémisants
- 1922 : 1^{er} patient DT1 traité par insuline
- Évolution : insulines animales (bœuf/porc) → insulines purifiées (1970) → insuline humaine (biosynthèse 1978-81) → analogues de l'insuline (1990)

II. DÉPISTAGE

- Facteurs de risque : surpoids, antécédents familiaux, macrosomie fœtale, HTA, dyslipidémie, tabac
- Recommandations : glycémie à jeun chez ≥ 45 ans tous les 3 ans (ADA)

III. CLASSIFICATION DES DIABÈTES

A. DIABÈTE DE TYPE 1 (DT1) - 5 à 10 %

- Destruction auto-immune des cellules β
- DT1a : auto-immun (rapide/enfant ou lent/adulte/LADA)
- DT1b : idiopathique
- Carence absolue en insuline

B. DIABÈTE DE TYPE 2 (DT2) - 90 à 95 %

- Insulinorésistance + défaut d'insulinosécrétion
- Forme la plus répandue

C. DIABÈTE GESTATIONNEL

- Troubles de la tolérance glucidique découverts pendant la grossesse
- 6 % des grossesses en moyenne

D. AUTRES TYPES SPÉCIFIQUES

- Génétiques : MODY (1 à 5), diabète mitochondrial (MIDD)
- Pancréatopathies : pancréatite, cancer, mucoviscidose
- Endocrinopathies : Cushing, acromégalie, hémochromatose
- Médicamenteux : corticoïdes, antiprotéases, interféron
- Infections : rubéole congénitale, coxsackie
- Syndromes génétiques : trisomie 21, Turner, Klinefelter

IV. PHYSIOPATHOLOGIE DT1

- Génétique : HLA DR3/DR4 (facteurs de risque), HLA DR2 (protecteur)
- Facteurs environnementaux : virus (rubéole, oreillons, coxsackie), toxiques
- Auto-immunité : anticorps anti-îlots (ICA), anti-GAD, anti-IA2, anti-ZnT8
- Destruction : 85-90 % des cellules β au diagnostic
- Risque : 0.4 % (général) → 50 % (jumeaux)

V. PHYSIOPATHOLOGIE DT2

- Défaut d'insulinosécrétion : anomalie de pulsatilité, perte du pic précoce
- Insulinorésistance :
 - Augmentation de la néoglucogenèse hépatique
 - Déficit du transport du glucose dans les tissus périphériques
- Facteurs acquis : obésité, sédentarité, âge, grossesse, stress
- Rôle des incrétones : GLP-1 et GIP (déficit chez DT2)

VI. DIAGNOSTIC CLINIQUE

Critère	DT1	DT2
Âge	< 35 ans	> 40 ans
Début	Rapide/explosif	Lent/insidieux
Poids	Normal/mince	Obésité
Glycémie	> 3 g/L	< 2 g/L
Cétose	Fréquente	Rare
Complications	Rénale	Cardiovasculaire

DÉFINITION ET CLASSIFICATION DU DIABÈTE SUCRÉ (2)

VII. LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)

- DT1 lent de l'adulte (30-70 ans)
- Anticorps positifs (GAD, IA2, ZnT8)
- Insulino-requérant en 5-10 ans
- Représente 10% des DT2
- Association fréquente avec thyroïdopathies auto-immunes (20-30%)

VIII. DIABÈTE GESTATIONNEL

1. Complications :
 - macrosomie fœtale, HTA, césarienne, détresse respiratoire
2. Risques à long terme :
 - récurrence, DT2 chez la mère, obésité de l'enfant
3. Dépistage :
 - 24-32 SA avec HGPO 75g

IX. MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)

1. MODY 2 :
 - hyperglycémie modérée, complications rares
2. MODY 1 et 3 :
 - formes sévères, complications possibles
3. MODY 5 :
 - diabète + kystes rénaux
4. Grossesse :
 - risque de macrosomie/hypotrophie selon le génotype fœtal

X. DIABÈTE MITOCHONDRIAL (MIDD)

- Mutation ARNT Leu 3243
- Signes d'orientation :
 - IMC < 30
 - surdit 
 - dystrophie maculaire r tinienne
 - ant c dent maternel

XI. BILAN IMMUNOLOGIQUE DT1

1. GAD en premi re intention
2. IA2 et ZnT8 si disponible
3. ICA abandonn  (impr cis)
4. 5-10% des DT1 sont Ac n gatifs
5. Attention :
 - Ac + chez adulte = risque de progression rapide vers insulinod pendance